

Tendencias epidemiológicas integradas de Costa Rica

2025-2026

Población adulta mayor y panorama nacional

Lectura ejecutiva

- Comparación de 72 boletines semanales y 5 mensuales.
- Énfasis en personas de 65 años y más.
- Cambios al mismo corte epidemiológico cuando fue posible.
- Prioridades de vigilancia y acción para 2026.

SÍNTESIS EJECUTIVA

Costa Rica 2025–2026 en una mirada

Indicadores comparables y señales prioritarias del último corte disponible

IRAG -39,7% 7.627 → 4.600 · SE 24	EDA +20,6% 197.139 → 237.833 · SE 24	DENGUE +8,0% 1.677 → 1.805 · SE 26
SÍFILIS 65+ +17,1% 129 → aprox. 151 · SE 24	MIASIS 65+ 52,2% 24 de 46 casos · SE 27	MENINGITIS +6,4% 109 → 116 · SE 26

Hallazgo central

La transición de 2025 a 2026 no muestra una mejora uniforme. Disminuyó la carga respiratoria total al mismo corte, pero aumentaron dengue, enfermedad diarreica aguda, meningitis y las infecciones de transmisión sexual. En la población adulta mayor, el riesgo se explica por la acumulación de vulnerabilidades más que por una sola enfermedad.

72

boletines semanales únicos revisados

5

boletines mensuales integrados

Nota de comparabilidad: se presentan comparaciones directas solo cuando el indicador y la semana epidemiológica son equivalentes. Los demás hallazgos se interpretan como trayectorias parciales.

POBLACIÓN ADULTA MAYOR

El grupo de 75 años y más concentra múltiples señales de vulnerabilidad

La vigilancia debe integrar enfermedad, dependencia, lesiones y condiciones psicosociales

01 Infecciosa grave IRAG y miasis. Los mayores de 75 se mantienen entre los grupos de mayor carga y gravedad potencial.	02 Infecciosa persistente Sífilis, meningitis y otras ITS. La transmisión y la necesidad de diagnóstico no desaparecen con la edad.
03 Lesiones y dependencia Heridas, caídas y accidentes domésticos. La seguridad del hogar y el cuidado continuo son determinantes.	04 Psicosocial Violencia, negligencia, abandono, aislamiento e intentos de suicidio requieren detección activa.

–39,7% IRAG totales al mismo corte; el descenso específico en 65+ no puede estimarse	+17,1% casos de sífilis en 65 años y más	699 muertes por otras causas externas en 65+ (datos 2025 divulgados en 2026)
--	--	--

	Lectura gerontológica La señal más importante no es una única enfermedad, sino la acumulación de riesgos en personas con dependencia, heridas crónicas, multimorbilidad o aislamiento. Esto justifica una vigilancia transversal separada para 65–74 y 75 años y más.
--	---

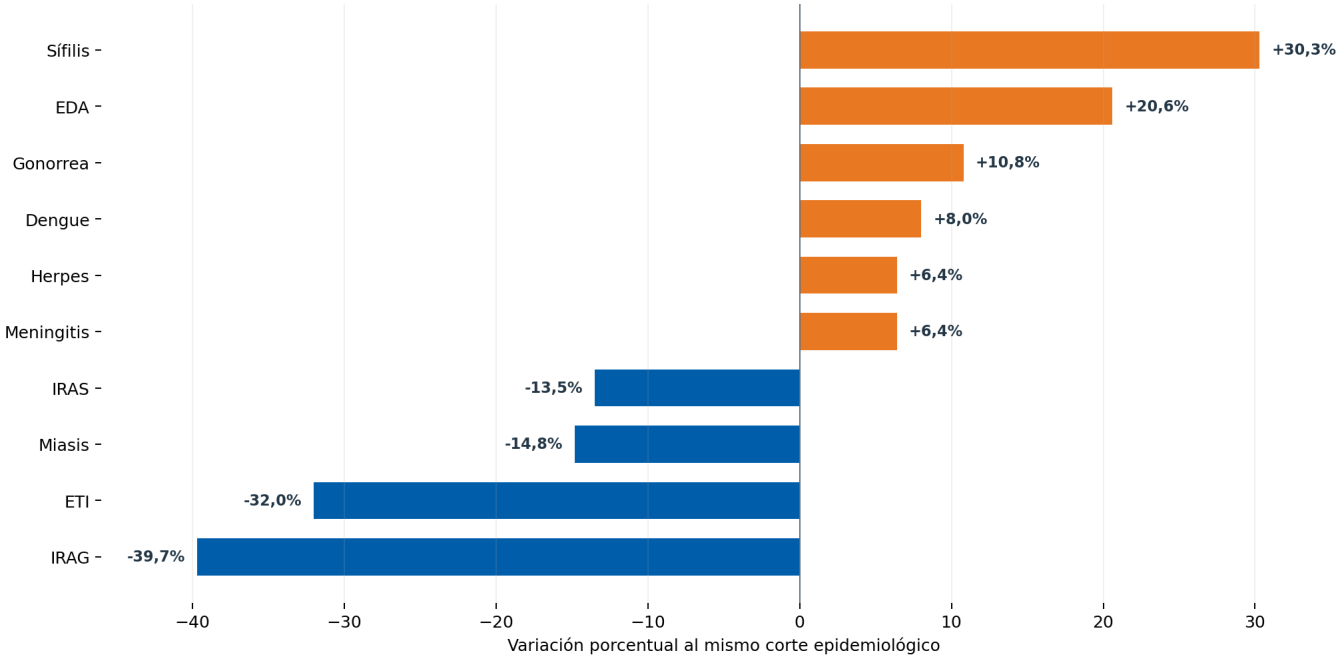
Fuente: Informe integrado de tendencias epidemiológicas 2025–2026. Datos recientes preliminares y sujetos a revisión.

COMPARACIÓN INTERANUAL

Qué aumentó y qué disminuyó en 2026

Cambios porcentuales en acumulados al mismo corte epidemiológico

Costa Rica: cambio interanual 2025 → 2026



Fuente: informe integrado CIOdD, con base en boletines de la Dirección de Vigilancia de la Salud.

Interpretación técnica

El ajuste por crecimiento poblacional es pequeño y no modifica el sentido de ninguna tendencia. La corrección desplaza los cambios entre 0,4 y 1,1 puntos porcentuales, por lo que las conclusiones sustantivas se mantienen.

SEÑALES DE AUMENTO

- Sífilis: +30,3%
- EDA: +20,6%
- Gonorrea: +10,8%
- Dengue: +8,0%
- Herpes y meningitis: +6,4%

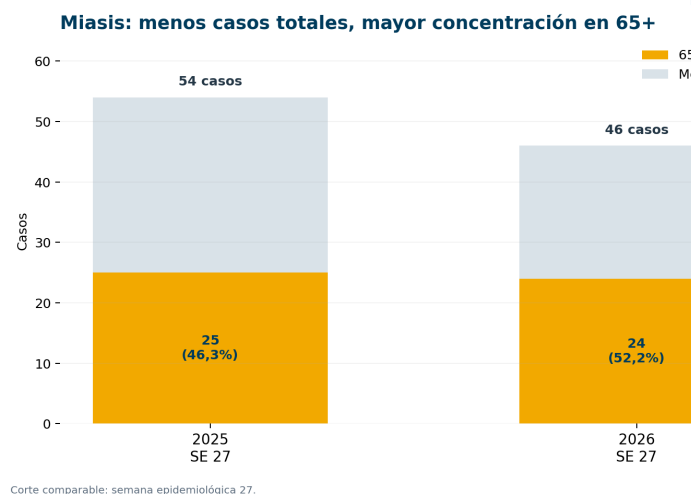
SEÑALES DE DISMINUCIÓN

- IRAG: -39,7%
- ETI: -32,0%
- Miasis: -14,8%
- IRAS: -13,5%

DOS SEÑALES CRÍTICAS

Miasis y sífilis en personas de 65 años y más

Menor número de miasis, pero persistencia de la concentración; aumento absoluto de sífilis



SÍFILIS EN 65+

129 → ≈151

+17,1% al corte de la SE 24

El número absoluto creció, aunque la participación proporcional bajó ligeramente porque el aumento fue más rápido en grupos jóvenes.

Implicación

La atención sexual y reproductiva debe incluir a las personas mayores, sin barreras por edad para tamizaje, diagnóstico y tratamiento.

Miasis como síndrome centinela

A la SE 27 los casos totales disminuyeron 14,8%, pero los casos en 65 años y más solo bajaron 4,0%. La participación de la población mayor aumentó de 46,3% a 52,2%. El evento debe leerse como señal de vulnerabilidad, cuidado insuficiente de heridas y dependencia, bajo un enfoque de Una Sola Salud.

Cortes comparables: miasis SE 27; sífilis SE 24. Las cifras de 2026 son preliminares.

CARGA COMUNITARIA Y GRAVEDAD

Respiratorio y enfermedad diarreica aguda

Menos notificaciones respiratorias al mismo corte, pero EDA en aumento y poblaciones vulnerables persistentes

ENFERMEDAD RESPIRATORIA

4.600 IRAG a la SE 24 de 2026

-13,5% IRAS al corte comparable

-32,0% ETI al corte comparable

La reducción nacional es favorable, pero no elimina la concentración de IRAG en mayores de 75 años ni la necesidad de preparación hospitalaria para el segundo semestre.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

237.833 casos a la SE 24 de 2026

+20,6% frente al mismo corte de 2025

2.102 tasa por 100.000 en 65+ (2026)

La fuente advierte rezago de notificación y no publica hospitalización, deshidratación o mortalidad por edad. La mayor circulación comunitaria incrementa la exposición de las personas mayores.

Lectura conjunta

La magnitud y la gravedad no siempre se mueven en la misma dirección

75+

grupo prioritario para IRAG por gravedad potencial

≥10%

subestimación reciente posible de EDA por rezago

Sin serie

de hospitalización y mortalidad por edad para EDA

Implicación operativa

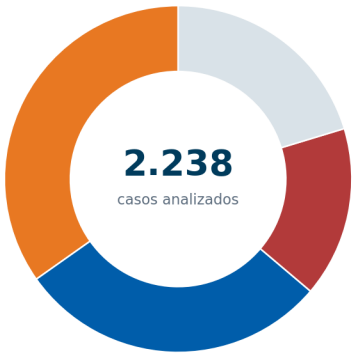
Preparar servicios para la temporada respiratoria, mantener vacunación y detección temprana en mayores de 75, y reforzar vigilancia de agua, alimentos y brotes territoriales de EDA.

RIESGOS NO INFECCIOSOS

Violencia, salud mental y mortalidad externa

La vigilancia epidemiológica de la vejez debe incluir dependencia, seguridad y protección social

Violencia intrafamiliar en personas adultas mayores (2025)



- Negligencia o abandono: 34,8%
- Abuso psicológico: 29,0%
- Abuso físico: 15,9%
- Otros diagnósticos: 20,3%

59%

de los casos correspondió a mujeres

478,2

tasa por 100.000 en personas de 75+ (SE 43 de 2025)

7,6

tasa de intentos de suicidio por 100.000 en 65+ (SE 42 de 2025)

699

muerter en 65+ por "otras causas externas"

17

homicidios en el mismo grupo

Prioridad sanitaria

La categoría de otras causas externas incluye caídas, ahogamientos y accidentes domésticos. La prevención debe incorporar evaluación del hogar, visión, audición, medicamentos, movilidad, detección de negligencia y evaluación de depresión y riesgo suicida.

Limitación: no existe un informe equivalente de violencia intrafamiliar e intentos de suicidio en los boletines revisados de 2026.

PANORAMA TERRITORIAL

Las prioridades cambian según región

El riesgo no se distribuye de forma homogénea y exige respuestas territoriales diferenciadas

Pacífico Central Alta tasa de dengue en ambos años; EDA y mortalidad infantil. DENGUE / EDA	Central Norte / Alajuela Mayor carga de dengue en 2026; malaria en Crucitas y Los Chiles; miasis. DENGUE / MALARIA / MIASIS
Huetar Caribe / Limón Malaria en Matina; tasas altas de ITS, IRAS y miasis. ITS / MALARIA / MIASIS	Central Sur / San José Gran volumen de dengue en 2025; ITS, EDA, meningitis y tuberculosis. ITS / EDA / DENGUE
Huetar Norte Malaria, IRAG y miasis. MALARIA / IRAG	Brunca Altas tasas de IRAG y exposición a eventos importados. IRAG
Chorotega / Guanacaste Dengue, EDA y mortalidad infantil. DENGUE / EDA	LECTURA TERRITORIAL En 2026 el dengue desplazó su mayor volumen hacia Central Norte y mantuvo alta intensidad en Pacífico Central, especialmente Orotina. La malaria se concentró en Crucitas y Los Chiles, sin desaparecer el riesgo del Caribe.

La priorización territorial combina volumen de casos, tasas y persistencia de focos; no implica que las demás regiones estén libres de riesgo.

AGENDA DE ACCIÓN

Prioridades para 2026

Medidas concretas para población adulta mayor y para el país

POBLACIÓN ADULTA MAYOR

- Vacunación respiratoria y detección temprana de IRAG, con foco en mayores de 75.
- Revisión sistemática de piel y heridas en atención domiciliaria, EBAIS y hogares de larga estancia.
- Ruta integrada para miasis entre salud humana, SENASA, cuidadores y servicios sociales.
- Tamizaje y tratamiento de ITS sin barreras por edad.
- Prevención de caídas mediante evaluación del hogar, visión, audición, medicamentos y movilidad.
- Detección de negligencia, abandono y violencia.
- Evaluación de depresión y riesgo suicida, especialmente en hombres mayores de 70.
- Indicadores separados para 65–74 y 75 años y más.

PRIORIDADES NACIONALES

- Intensificar control vectorial del dengue en Orotina, Pacífico Central y Central Norte.
- Reforzar vigilancia de EDA, agua y alimentos en territorios de alta incidencia.
- Mantener búsqueda activa de malaria en Crucitas, Los Chiles y Matina.
- Expandir prevención, diagnóstico y tratamiento de sífilis y gonorrea.
- Preparar servicios para la temporada respiratoria del segundo semestre.
- Mantener vacunación y respuesta rápida ante sarampión importado.
- Integrar salud mental y violencia en la vigilancia rutinaria.

Recomendación estructural

Adoptar una vigilancia gerontológica transversal: cada evento debería publicar casos, tasas, hospitalizaciones y defunciones para 65–74 y 75 años y más. Sin esa desagregación, la respuesta continuará dependiendo de gráficos y análisis parciales.

RIGOR Y TRAZABILIDAD

Brechas de información y conclusiones

Qué puede afirmarse, qué no puede compararse y qué debe fortalecerse

Brechas principales

01 Sin cortes finales completos de 2025	02 Semanas epidemiológicas diferentes entre eventos	03 Falta de tablas numéricas por edad para IRAG y meningitis	04 Sin hospitalización y mortalidad por edad para EDA
05 Sin seguimiento equivalente de violencia y suicidio en 2026	06 Categorías etarias no uniformes	07 Datos preliminares y revisables	08 Sin microdatos para ajustes por edad, comorbilidad y territorio

Conclusión

	Una transición epidemiológica desigual Durante el primer semestre de 2026 disminuyó la carga respiratoria total, pero aumentaron dengue, EDA, meningitis e ITS. La malaria registró más transmisión local al mismo corte, aunque en niveles muy inferiores a los años de mayor actividad. La miasis disminuyó, pero sigue concentrándose en personas mayores.
	La vejez requiere una lectura integral Para las personas de 65 años y más, las prioridades exceden las enfermedades transmisibles: IRAG, miasis, sífilis, caídas, heridas, violencia, negligencia y salud mental conforman un mismo perfil de vulnerabilidad. Los mayores de 75 años son el grupo de mayor prioridad.

Ficha técnica

Fuente principal	Boletines epidemiológicos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.
Cobertura	47 boletines semanales únicos y 1 mensual de 2025; 25 boletines semanales y 4 mensuales de 2026.
Criterio	Comparación directa solo con el mismo indicador y la misma semana epidemiológica; los demás resultados se presentan como tendencias parciales o hallazgos exclusivos.
Elaboración	Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad de Costa Rica. 25 de julio de 2026.